ONEMA-POP-006 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-006 — Acolhimento de Crise de Ansiedade e Ataque de Pânico — Segurança e Diagnóstico Diferencial

1. Identificação institucional

983558

2. Objetivo e abrangência

Acolher sofrimento agudo sem rotular prematuramente sintomas potencialmente orgânicos e estabelecer encaminhamento seguro. Atendimento domiciliar presencial ou orientação digital conforme indicação; não substitui assistência de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro: acolhimento, avaliação de risco, apoio não farmacológico, documentação e encaminhamento; diagnóstico médico e prescrição não são presumidos. Indicações: Queixa de medo súbito, palpitações, tremores, sensação de sufocamento, parestesias, agitação ou ansiedade intensa. Limites/contraindicações: Não classificar como pânico, nem tranquilizar como condição benigna, diante de dor torácica nova, síncope, dispneia importante, déficit focal, hipoglicemia

possível, intoxicação, gravidez com sinais de risco ou ideação suicida.

4. Materiais e responsabilidade de fornecimento

Enfermeiro presencial: aparelho de pressão, oxímetro, estetoscópio, termômetro, glicosímetro quando indicado e disponível, EPI e telefone. Paciente: relação de medicamentos, contatos e histórico; nenhum medicamento sedativo de rotina é previsto.

5. Avaliação e preparação

Investigar início, duração, sintomas, fatores precipitantes, episódios anteriores, cardiopatia, diabetes, uso de substâncias

e medicamentos; sinais vitais presencialmente; risco de autoagressão, psicose, confusão e ambiente inseguro.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Identificar paciente, local, acompanhante e garantir ambiente seguro, privado e com estímulos reduzidos.

2. Realizar triagem imediata de dor torácica, dispneia grave, síncope, déficit neurológico, alteração de consciência,

convulsão e risco suicida; se presentes, acionar emergência ou serviço de crise conforme gravidade.

3. No presencial, verificar sinais vitais e glicemia quando clinicamente indicada; em teleatendimento registrar limitações

de exame físico e baixa tolerância a incerteza diagnóstica.

4. Apresentar-se, usar frases curtas e calmas, escutar sem julgamento e explicar que sintomas físicos precisam ser

avaliados; não afirmar que é apenas ansiedade.

5. Convidar o paciente a respirar de modo confortável e regular, sem forçar inspirações profundas nem usar saco de

papel; interromper se houver piora.

6. Identificar rede de apoio e perguntar diretamente sobre pensamentos de se ferir, plano e acesso a meios quando

houver sinais de risco; não deixar pessoa de alto risco desacompanhada.

7. Reavaliar sintomas e sinais objetivos após acolhimento; sintomas novos, persistentes ou atípicos exigem avaliação

presencial, mesmo que ansiedade esteja presente.

8. Se sem sinais de alarme após avaliação apropriada, orientar consulta de seguimento em atenção primária/saúde

mental, recursos de apoio e retorno diante de piora.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Acionar SAMU 192 em emergência clínica, alteração de consciência ou risco iminente à vida; diante de risco de autoagressão, acionar rede de urgência e proteger paciente sem prometer sigilo absoluto.

8. Cuidados posteriores e orientações

Oferecer orientações simples, rede de apoio e encaminhamento; evitar rótulos diagnósticos definitivos e intervenções farmacológicas sem prescrição.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação e consentimento; modalidade; horário de início e evolução; queixas, antecedentes e sinais objetivos; avaliação e decisão clínica; ações e responsáveis; acionamentos e horários; resposta, orientações, destino e continuidade; assinatura do enfermeiro e trilha de auditoria na Carteira Digital ONEMA.

10. Referências técnicas rastreáveis

NICE CG113. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults — recomendações
https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/chapter/Recommendations
NHS. Panic disorder — avaliação e diferenciais
https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/panic-disorder/
AHA/ACC. 2021 Guideline for Evaluation and Diagnosis of Chest Pain
https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2021.07.053
Pontos para revisão do RT: escopo de autonomia e protocolos locais; aplicabilidade ao atendimento remoto; compatibilidade de insumos e dispositivos; fluxo de referência/contrarreferência; verificação de versão e seção de cada fonte.